

ITEM 279 : MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE DE L'INTESTIN

MALADIE DE CROHN

- = Affection inflammatoire chronique de cause inconnue pouvant atteindre tous les segments du tube digestif
- Prévalence = 1/1000, début à tout âge avec un pic de fréquence à 20-30 ans, gradient Nord > Sud
- FdR reconnus : **tabagisme actif, antécédents familiaux (polymorphisme génétique : mutation du gène CARD15-NOD2...)**

Diagnostic	Atteinte digestive	= Peut atteindre l'ensemble du tube digestif, évolue en 3 phases : inflammatoire, sténosante et perforante - Atteinte : iléale pure (20%), colique pure (30%), iléo-colique (30%), tube digestif haut (15%) → Evocateur : diarrhée prolongée, lésion proctologique atypique/récidivante ou douleur abdominale inexplicée	
		Bouche	- Aphtes récidivants
		Œsophage, estomac	- Oesophagite, gastrite - Ulcère gastroduodénal
		Intestin grêle	- Douleur abdominale - Syndrome de Kœnig (occlusion transitoire) - Malabsorption
		Colon	- Douleur abdominale - Syndrome abdominal aiguë - Syndrome dysentérique
		Rectum	- Syndrome rectal : épreinte, ténésme, faux besoins, impériosité, diarrhée glaireuse
		Anus	- Fissure , notamment atypique : indolore, localisation latérale - Fistule, sténose, pseudo-marisque, abcès, ulcère
	Extra-digestive	Signes généraux	- AEG, amaigrissement - Retard de croissance chez l'enfant, retard pubertaire chez l'adolescent
		Articulaire (25-30%)	- Polyarthrite périphérique : corrélé aux poussées intestinales - Spondylarthropathie axiale : non corrélée à l'évolution intestinale - Ostéoarthropathie hypertrophiante : hippocratisme digital
		Cutanée (15%)	- Erythème noueux : éruption douloureuse bilatérale, papules surélevées, nodules érythémato-violacés, fermes et mobiles, de quelques mm/cm, sur les faces d'extension des bras et des jambes - Aphthose buccale - Pyoderma gangrenosum : en cas de maladie de Crohn avec atteinte colique, peu fréquent
		Oculaire (< 10%)	= Plus fréquente chez la femme ou en cas d'atteinte colique - Uvéite antérieure aiguë : souvent bilatérale - Episclérite
		Hémato	- Anémie (mixte inflammatoire et carencielle) et thrombocytose - Syndrome inflammatoire
		Autres	- Hépto-biliaire : cholangite sclérosante primitive, stéatose - Autres : thyroïdite, pancréatite, atteinte pulmonaire, rénale...
	Bio	- NFS, CRP, fibrinogène, EPS (hypo-albuminémie, hyper- α_2), coproculture, bilan hépatique et rénal - Inflammation digestive : ↑ du taux fécal de calprotectine - Bilan immunologique : ASCA (dans 50% des Crohn et 5% des RCH), ANCA (dans 20% des Crohn et 70% des RCH) - Bilan nutritionnel + malabsorption : vitamines B9, B12, A, D, E, K, hémostase, ferritinémie, bilan phosphocalcique - Bilan pré-thérapeutique : β-hCG, activité et génotype TPMT (AZT ou 6-MP), bilan anti-TNFα	
	PC	Endoscopie	= Endoscopie oeso-gastro-duodénale + iléo-coloscopie avec biopsies de lésions et en zones saines
			Macroscopie = Lésions discontinues avec intervalles de muqueuse saine : - Ulcérations : aphtoïdes, superficielles ou profondes - Evolution : fissure, fistule, sténose, pseudo-polype cicatriciel
			Histologie = Atteinte trans-murale (pan-colite) : - Ulcérations (perte de substance muqueuse), abcès cryptiques, villosités irrégulières, distorsions glandulaires - Infiltration lympho-plasmocytaire du chorion muqueux, voire transmural - Granulome épithélioïde et géiganto-cellulaire sans nécrose caséuse (30%)

Diagnostic	PC	Entéro-scanner ou Entéro-IRM	= Scanner/IRM après ingestion orale de 1,5-2L d'eau ou de méthylcellulose à 5%, ou par une sonde naso-jéjunale (entéroclyse) : recherche d' atteinte iléale distale , présente dans 2/3 des cas - Lésions : épaississement des parois avec ulcérations, hyperhémie des mésos (signe du peigne), épaississement de la graisse mésentérique, parfois ADP de voisinage - Caractéristique : segmentaires (alternance de zones d'intestin sain et malade) et asymétriques - Complication : sténoses et/ou fistules	
		Autres	- Vidéocapsule ou entéroscopie (± biopsies) parfois indiquées	
Diagnostic différentiel	Iléo-colite		- Maladie de Crohn : début à type de diarrhée aiguë dans 10% des cas (tableau de gastro-entérite) → à explorer si diarrhée persistante > 3 jours sous traitement symptomatique - Endoscopie : lésions iléo-coliques + biopsies en zone saine et pathologique → La mise en route à tort d'un traitement corticoïde/immunosuppresseur pour une colite infectieuse non diagnostiquée peut avoir des conséquences graves	
	Iléite aiguë isolée		= Infection intestinale, notamment à Yersinia enterocolitica , plus rarement à Campylobacter , Salmonella ou parasitaire (Anisakis simplex) par ingestion de poisson cru) - Diagnostic : coproculture ± hémoculture si fièvre, culture de biopsie de muqueuse iléale, sérologie - CAT devant une iléite aiguë fébrile : - Antibiothérapie par quinolone après coproculture et hémoculture - Iléo-coloscopie + biopsie si symptômes persistant - Si l'histologie n'est pas discriminante entre infection ou Crohn : des lésions endoscopiques et/ou radiologique iléale persistant > 6 mois éliminent l'infection et évoquent fortement un Crohn	
	Tuberculose		= Tuberculose intestinale : contamination hématogène, déglutition, alimentaire (rare) ou par contiguïté, atteinte principalement iléo-caecale , mais parfois colique segmentaire unique ou multifocale (25%) - Contexte : - Atcd personnel de tuberculose ou tuberculose active (pulmonaire dans 20% des cas) - Contage, FdR (migrant, conditions socio-économiques défavorables, immunodépresseion) - AEG, fièvre, masse en FID, diarrhée inconstante, ascite exsudative - Biopsies intestinales : - BAAR à l'examen direct (très rare), cultures sur milieu de Löweinstein (40%) - PCR BK : valeur diagnostic faible sur biopsie intestinale - Nécrose caséuse dans les granulomes : spécifique, présent dans 50% des cas - Arguments moins formels : contage, IDR/Quantiféron, atteinte pulmonaire séquellaire ou active - En cas de doute persistant : traitement d'épreuve antituberculeux	
	Autres		= Lésions suspendues ulcérées de l'intestin grêle : - Lésion néoplasique ulcérée : adénocarcinome, lymphome - Maladie de Behçet, vascularite ou granulomatose chronique septique (déficit de phagocytose)	
Evolution	- Evolution par poussées séparées de période de rémission (parfois presque continue), guérison spontanée exceptionnelle - Aggravation progressive : fibrose sténosante (stade sénosant), fistule et abcès (stade perforant ou pénétrant) → Chirurgie envisagée au stade de complication : > 50% des malades dans les 10 ans suivant le diagnostic			
	Causes de diarrhée chez une MICI		- Poussée inflammatoire - Infectieuse : colonisation chronique, surinfection à C. difficile ou CMV, dysentérie, IST - Anatomique : grêle court, malabsorption, fistule interne - Iatrogène : AINS, antibiothérapie, intolérance médicamenteuse	
	Complications		- Oclusion sur sténose inflammatoire ou fibreuse - Fistule, abcès et perforation - Hémorragie plus rarement	- Colite aiguë grave, voire colectasie - Adénocarcinome en zone affectée : ↗ le risque de cancer colique ou de l'intestin grêle
TTT	Traitement des poussées		- Corticoïdes locaux = budésonide par voie orale ou en lavement : en 1 ^{ère} intention si poussée modérée de topographie iléale terminale ou iléo-colique - Corticoïdes systémiques (1 mg/kg) : d'emblée si poussée sévère ou non accessible aux corticoïdes locaux - Traitement nutritionnel : alimentation entérale à débit continu ou alimentation parentérale exclusive - Anti-TNFα si résistance ou intolérance aux corticoïdes ou en cas de forme de mauvais pronostic	
	Traitement d'entretien		= Immunosuppresseurs : but = maintien d'une rémission profonde, durable et sans corticoïdes - Analogue de purine en 1 ^{ère} intention : azathioprine ou 6-mercaptopurine - En 2 nd intention : méthotrexate et/ou anti-TNFα	
	Chirurgie		= Indiquée en cas de complication mécanique : perforation, sténose ou fistule symptomatique - Ablation des segments d'intestin pathologique → Ne protège pas des récides	
	Mesures associées		- Sevrage total et définitif du tabac - Traitement symptomatique : antalgique (éviter les AINS), antispasmodique, anti-diarrhéique - PEC nutritionnelle : consultation diététique	

RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE

RCH = maladie inflammatoire chronique du colon atteignant constamment le rectum et s'étendant de manière continue sans intervalle sain vers le caecum (de la **rectite** à la **pan-colite**), sans atteinte iléale, digestive haute ou ano-périnale
- Prévalence = 1/1000 : à tout âge, gradient Nord > Sud, facteurs protecteurs = **tabac, appendicectomie**

			- Diarrhée prolongée , surtout hémorragique
--	--	--	---

Diagnostic	C	Atteinte digestive		- Syndrome dysentérique - Syndrome rectal : impériosité, faux besoins		
			Critères de Truelove-Witts	= Poussée de RCH : légère, intermédiaire ou sévère (= colite aiguë grave)		
					Légère	Sévère
			Nombre d'évacuations/24h Rectorragies Température Fréquence cardiaque Hémoglobine VS	< 4 Traces < 37,5° < 90 bpm ≥ 10,5 g/dl < 30	≥ 6 Importantes ≥ 37,5° ≥ 90 bpm < 10,5 g/dl ≥ 30	
		Atteinte extra-digestive	- Asthénie, amaigrissement, retard de croissance ou pubertaire, anémie, syndrome inflammatoire - Atteinte articulaire, oculaire, hématologique et cutanée : identique au Crohn - Anémie hémolytique auto-immune - Cholangite sclérosante primitive (associée dans 90% des cas à une RCH, plus rarement à un Crohn) : risque de cholangiocarcinome et cirrhose biliaire secondaire			
	PC	Coloscopie + iléoscopie	→ Rectum toujours atteint : proctite isolée (1/4), rectocolite gauche (1/2), pan-colite (1/4)			
			Macroscopie	= Atteinte continue, commence dès la jonction anorectale, étendue plus ou moins loin, s'interrompant de façon brusque - Anomalies du réseau vasculaire muqueux, puis muqueuse granitée, fragile, saignant au contact puis érosions, ulcérations, voire ulcère étendu (« en puits ») - Perte de la muco-sécrétion		
			Histologie	= Atteinte muqueuse superficielle : - Bifurcation et distorsion glandulaire - Infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion - Plasmocytose basale		
		Bili-IRM	= Dépistage de cholangite sclérosante primitive en cas d'anomalie du bilan hépatique			
	DD	- Diarrhée aiguë révélant une colite : souvent hémorragique, indiquant immédiatement la réalisation d'une coloscopie - Recto-sigmoïdite aiguë/subaiguë: IST (syphilis, gonocoque, Chlamydia, herpes), amibiase intestinale, colite ischémique				
Complication	- Evolution par poussée, séparées de périodes de rémissions, parfois sur un mode presque continu avec exacerbations					
	Colite aiguë grave		= Poussée de RCH sévère : survient chez 20% des patients, parfois inaugurale			
		Complication	- Hémorragie digestive basse - Colectasie → méga-colon toxique si défaillance viscérale - Perforation: péritonite stercorale - Accident thrombo-embolique			
		PEC	- Corticothérapie systémique IV en 1 ^{ère} intention - Ciclosporine ou anti-TNFα si échec à 3 jours - Colectomie chirurgicale si échec à 5 jours			
	Néoplasique	= Risque augmenté de cancer colorectal : surveillance coloscopique régulière - FdR : atteinte étendue et ancienne (> 10 ans), cholangite sclérosante associée				
TTT	TTT médical	TTT des poussées	- 5-ASA en 1 ^{ère} intention : par voie orale ou locale (suppositoire, lavement) - Si échec ou forme sévère : corticoïdes, voire anti-TNFα ou ciclosporine en 2 nd intention			
		TTT d'entretien	- 5-ASA (dérivés 5-amino-salicylés) : suffisant chez 50% des malades - Analogue de purine (azathioprine, 6-mercaptopurine) et/ou Ac anti-TNFα en 2 nd intention			
	TTT chirurgical	= Colo-proctectomie totale + reconstruction par anastomose iléo-anale avec réservoir : 15% des malades - Indication : - Echec du traitement médical : - Colectomie de sauvetage en cas de colite aiguë grave - Chirurgie programmée en cas de forme chronique réfractaire - Lésion pré-néoplasique ou cancer colorectal - EI : diarrhée motrice, troubles de la continence → Aucune récidence après chirurgie				

Diagnostic différentiel		MALADIE DE CROHN	RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE
FdR	Génétique	Mutation CARD15-NOD2	∅
	Tabagisme	Facteur de risque : 30 à 50% des cas	Facteur protecteur : < 10% des cas
	Appendicectomie	Fréquence = population générale	Facteur protecteur
Lésion macroscopique	Atteinte continue	Possible	Toujours
	Intervalle de muqueuse saine	Fréquent	Jamais
	Atteinte rectale	25% des cas	Constante
	Ulcérations iléales	60% des cas	Jamais
	Lésion ano-périnéale	50% des cas	Jamais
	Sténose/fistule	Fréquentes	Jamais
Histo	Inflammation	Transmurale	Superficielle
	Muco-sécrétion	Peu altérée	Très altérée
	Granulome épithélioïde	30% des cas	Jamais
Sérologie	ASCA	Souvent positif	Négatif
	ANCA	Négatif	Souvent positif
Colite inclassée		= 10 à 20% des cas : si diagnostic différentiel non possible	

COLITE MICROSCOPIQUE				
= Diarrhée chronique souvent abondante, avec aspect endoscopique muqueux normal : incidence ≈ Crohn/RCH - Terrain : femme > 50 ans, associée 1 fois sur 2 à une maladie auto-immune (maladie coeliaque, diabète de type 1, vitiligo, thyroïdite de Hashimoto...) ou inflammatoire (PR) - 2 types histologiques : colite lymphocytaire ou colite collagène - Cause : - Idiopathique - Médicamenteuse : veinotonique, lanzoprazole, ticlopidine... → réversible à l'arrêt du traitement				
Diagnostic	C	- Diarrhée chronique : souvent fluctuante, diurne et nocturne, avec faux besoins et impériosités ± amaigrissement - Selles liquides, abondantes, réparties dans la journée - Déficit hydrosodé et hypokaliémie possible → Débute dans 50% des cas de façon aiguë (tableau de gastro-entérite)		
	PC	Endoscopie	Macroscopie	- Muqueuse d'aspect normal
			Histologie	- Anomalie aspécifique : - Perte d'intégrité de l'épithélium de surface - Infiltrat inflammatoire de la <i>lamina propria</i> avec prédominance de cellules mononuclées - Colite lymphocytaire : ↗ nombre de lymphocytes intra-épithéliaux ≥ 20%, CD8+ - Colite collagène : ↗ épaisseur de la bande collagène sous-épithélial > 10 µm
	TTT	→ Evolution imprévisible et capricieuse : atténuation spontanée en quelques années - En cas de diarrhée chronique : - Traitement symptomatique : ralentisseur du transit, racécadotril, colestyramine ± Budésonide à libération intestinale et colique		